EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 82739
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-04-18 10:26:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LEONEL ENRIQUE MARIN LANDERO			RUN	: 9.175.194-1
F.Nac	: 16-03-1964	Edad	: 60 AÑOS, 1 MES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 974811929/989146666		
Fecha Ingreso	: 2024-04-11	Fecha Egreso	: 2024-04-18 10:26:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I61.1-HEMORRAGIA INTRACEREBRAL EN HEMISFERIO, CORTICAL

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-HIC tálamo-capsular derecha, ICH 2
-ITU 2/7
-Hiponatremia leve
-Ant: HTA s/tto, OH crónico suspendido

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I61-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Rankin 0, sin antecedentes. El 01/04 /24 presenta en forma subita cefalea, nauseas, vomitos, y lipotimia con posterior paresia del hemicuerpos izquierdo. ExNL Vigil, desorienatdo TE, PFC izq, Plejia braquicrural izquierda. TAC de encefalo HIC ganglionar derecha con vaciamiento ventricular y efecto de masa 28 cc, ICH=2. Se presenta caso a Neurologo de turno se sugiere monitoreo estricto con manejo activo de presión arterial para manejar PAS entre 130-140, instalación de línea arterial y manejo en UPC. Durante hospitalización en UPCA se realizan TAC de cerebro s/c los días 1, 3 y 5 de abril; último TAC presenta mayor edema perilesional se maneja con SSH 10% por 48 hr sin requerir asistencia ventilatoria ni DVA, Evolcuiona con Delirio por privacion OH se maneja con BDZ y Tiamina. El 9/4/24 se traslada a UTAC. ExNL Vigil, inatento, orientado parcial TE, hemianopsia hom izquierda, hemiplejia izquierda, hemihipostesia leve izquierda, NIHSS=16, mRS=5. Con Disfagia severa requiere SNG. Se decide tarslado H San Carlos para avanzar en rehabilitaciòn y plan de alta, seguimiento por Neurologìa

Evolución
Paciente BEG, HDN estable, eupneico, afebril, cooperador, no refiere molestias. Tolera bien alimentación VO consistencia papilla.
Exs de lab de control destaca descenso de transaminasas y PCR, hiponatremia leve, sin leucocitosis, HC negativos a la fecha, urocultivo(+) para Enterobacter cloacae sensible e ciprofloxacino, cotrimoxazol, piperacilina/tazobactam y gentamicina. Cambio a cotrimoxazol VO e inicio manejo farmacológico para control de ansiedad. Suspendo espironolactona por hiponatremia.
Decido alta a domicilio hoy y control ambulatorio en policlínico de Neurología.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-Control ambulatorio en policlínico de Neurología
-IC HODOM para KNTM

INDICACIONES AL ALTA

1. -Losartan 50 mg c/12h
2. -Amlodipino 10 mg/día
3. -Metildopa 250 mg 2 comp c/8 horas
4. -Hidralazina 50 mg 2 comp c/8 horas
5. -Furosemida 40 mg 1/2 comp c/12 horas
6. -Omeprazol 20 mg/día
7. -Cotrimoxazol 800/160 mg 1 comp c/12 horas por 6 días
8. -Sertralina 50 mg/día, después del desayuno
9. -Clonazepam 0.5 mg 1/2 comp c/12 horas

EXÁMENES Y RESULTADOS

18/4/24
-Crea 1 MDRD 76.22 Uremia 41
-FA 83 BI 0.55 BD 0.25 BT 0.8 GOT 56 GPT 139 GGT 231
-PCR 62.9
-Na 131 K 4.3 Cl 98
-Leu 5100 Hb 13.6 Plaq 212000 Seg 68 VHS 63
-Procal 1.91

17/4/24
-PCR 169.8
-Na 133 K 4.6 Cl 99
-Hto 38.4 Hb 13.5
-OC GR 6-10 GB 26-50 bact escasas

TC tórax 16/4/24
-Cardiopatía izquierda (cardiomegalia moderada-severa de predominio izquierdo)
-Alteraciones parenquimatosas en gran parte por deficiente inspiración y movimiento respiratorio
-No se observan alteraciones agudas significativas

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-), flebitis(-), adenopatías(-), artritis(-)
-Cardiaco: RR 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) SRA
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas ni visceromegalia
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos pedio derecho débil

Ex neurológico:
-Mental: conservado
-PC: CV impresiona hemianopsia izquierda por amenaza, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC izq leve, disartria leve, nistagmo(-), úvula central, elevación palatina simétrica, fuerza ECM M5, fuerza trapecio izq M0 y der M5
-Motor: BC izq M0-1 (logra leve flexión de dedos y ortejos), BC der M5, RCP extensor izquierdo y flexor derecho
-Sensitivo: hipoestesia táctil FBC izq moderada
-Cerebelo: conservada a derecha, n/e a izq por plejia
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO